

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA CONCIENCIA INTEROCEPTIVA (MAIA-2)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación de la Sensibilidad, Confianza y Regulación Somatosensorial

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Evaluación Multidimensional de la Conciencia Interoceptiva - Versión 2 (MAIA-2).
Nombre Original (Inglés)	<i>Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA-2)</i>
Autores Originales	Drs. Wolf E. Mehling et al. (2012, 2018), University of California, San Francisco (UCSF).
Adaptación Española	Leidy Johana Vivas Rivas et al.; Valenzuela-Moguillansky et al. (2017).
Eje Clínico y Clasificación	Eje II: Procesos Psicológicos. Neurobiología de la Interocepción y Procesamiento Somático.
Tipo de Instrumento	Autoinforme dimensional de 37 reactivos con escala Likert de 6 puntos (0 a 5).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (desde los 16 años). Dolor crónico, trauma somático, psicoterapia y mindfulness.
Tiempo de Administración	6 a 10 minutos en autoadministración; 12 minutos asistido.
Régimen de Licencia	Acceso abierto institucional (UCSF Osher Center) bajo condiciones de atribución no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA INTEROCEPCIÓN

La MAIA-2 representa el estándar de referencia mundial para operacionalizar la **conciencia interoceptiva**: la percepción consciente, discriminación y modulación de las señales fisiológicas que emanan del interior del cuerpo (frecuencia cardíaca, respiración, tono muscular y propiocepción visceral). A diferencia de las escalas clásicas de somatización (que evalúan hipervigilancia hipocondríaca patológica), la MAIA-2 distingue entre la hiperreactividad ansiógena y las dimensiones reguladoras adaptativas del cuerpo.

Neurobiológicamente, la interocepción tiene su estación central en la corteza insular anterior (AIC) y el córtex cingulado anterior dorsal. Mientras la ínsula posterior recibe el mapa sensorial primario visceral, la ínsula anterior integra estas aferencias con señales afectivas y cognitivas para generar el “sentimiento consciente del Yo” (A.D. Bud Craig; Antonio Damasio). Una interocepción adaptativa permite utilizar las señales corporales como un ancla segura de autorregulación emocional, mientras que su desconexión o distorsión subyace a la alexitimia, el trauma complejo y los trastornos somatomorfos.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión Interoceptiva	Ítems (37)	Sentido	Operacionalización Clínica y Fenomenológica
1. Notar (Noticing)	1 al 4 (4)	Directo	Percepción consciente de sensaciones corporales neutras, placenteras o incómodas.
2. No-Distraerse	5 al 10 (6)	Inverso	Tendencia a no ignorar ni tapar el dolor o la tensión corporal mediante distracciones forzadas.
3. No-Preocuparse	11 al 15 (5)	Inverso	Capacidad de no catastrofizar ni angustiarse ante sensaciones físicas displacenteras.
4. Regulación Atencional	16 al 22 (7)	Directo	Habilidad para focalizar, sostener y reorientar la atención consciente en el cuerpo.
5. Conciencia Emocional	23 al 27 (5)	Directo	Reconocimiento de la relación biunívoca entre estados emocionales y sensaciones corporales.
6. Autorregulación	28 al 31 (4)	Directo	Habilidad para mitigar el distrés psicológico conectando conscientemente con el cuerpo.
7. Escucha Corporal	32 al 34 (3)	Directo	Escucha activa de las sensaciones internas como guía intuitiva para la toma de decisiones.
8. Confianza Corporal	35 al 37 (3)	Directo	Vivencia del cuerpo como un espacio seguro, continente y digno de confianza biológica.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Consistencia Interna	Alfas de Cronbach consistentes en adaptaciones hispanas: oscilan entre 0.68 (No-Distraerse) y 0.88 (Autorregulación y Confianza Corporal) (Valenzuela-Moguillansky et al., 2017).	
Estructura	Octodimensional	El AFC confirma el modelo de 8 factores correlacionados (CFI = 0.94, RMSEA = 0.048), superando holgadamente los modelos unifactoriales y validando la diferenciación clínica de facetas.
Validez Concurrente y Divergente	Correlaciones directas robustas con facetas de mindfulness (FFMQ, $r = 0.55$) y regulación emocional (ERQ-RC); e inversas con alexitimia (TAS-20, $r = -0.48$) y somatización catastrófica.	
Sensibilidad al Cambio	Excepcional sensibilidad a terapias somáticas (Somatic Experiencing), yoga terapéutico, MBSR y protocolos centrados en el cuerpo para el tratamiento del trauma y dolor.	
Invarianza Clínica	Validada en poblaciones con dolor crónico, fibromialgia, trastornos de la conducta alimentaria y atletas de alto rendimiento.	

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

Cada uno de los 37 ítems se califica en una escala de 0 a 5 (0 = «Nunca», 1 = «Rara vez», 2 = «A veces», 3 = «A menudo», 4 = «Muy a menudo», 5 = «Siempre»):

- **Paso 1 (Inversión de Reactivos):** Invertir los ítems de las escalas disfuncionales **No-Distraerse (5 al 10)** y **No-Preocuparse (11 al 15)**: 0 → 5, 1 → 4, 2 → 3, 3 → 2, 4 → 1, 5 → 0.
- **Paso 2 (Cálculo por Subescala):** Se calcula la **media aritmética** de los ítems de cada subescala (sumar los ítems y dividir por el número de ítems de la escala). Rango de cada media: **0.0 a 5.0**.
- **Regla Metodológica:** No se recomienda una puntuación total global sumada, sino la representación gráfica del perfil interoceptivo en sus 8 dimensiones.

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PERFILES DE INTEROCEPCIÓN

Nivel Medio	Puntuación M	Estado Interoceptivo	Significación Clínica y Pronóstico
Bajo / Desconectado	0.0 a 2.2	Desconexión corporal o fobia somática	En Confianza o Autorregulación: el cuerpo es percibido como enemigo o fuente de dolor inmanejable.
Medio / Típico	2.3 a 3.4	Sensibilidad interoceptiva moderada	Nivel poblacional habitual. Capacidad intermitente de registrar señales corporales.
Alto / Integrado	3.5 a 5.0	Conciencia corporal adaptativa (≥ 3.5)	Elevada autorregulación somática. Factor protector de resiliencia frente a la somatización y estrés.

EL PERFIL PATOGENICO DE SOMATIZACIÓN ANSIOSA:

El perfil de máximo riesgo en dolor crónico y trastorno de pánico combina **Alto Notar ($M > 4.0$)** con **Bajo No-Preocuparse ($M < 2.0$)** y **Baja Confianza Corporal ($M < 2.0$)**. Este paciente hipervigila cada latido o punzada interpretándola como signo de catástrofe médica inminente.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA EN TERAPIA SOMÁTICA Y MINDFULNESS

INTERVENCIÓN MODULAR SEGÚN EL PERFIL MAIA-2:

- **Si No-Preocuparse es bajo (< 2.0):** Fomentar la desensibilización sistemática a sensaciones internas (exposición interoceptiva) y psicoeducación sobre la benignidad de las respuestas autonómicas del cuerpo.
- **Si Confianza Corporal es baja (< 2.0):** Frecuente en pacientes con trauma o cirugías repetidas. Evitar relajaciones forzadas; trabajar primero la sensación de seguridad y apoyo del suelo (grounding y orientación visual externa).
- **Si Autorregulación y Regulación Atencional son bajas (< 2.5):** Entrenar ejercicios breves de escaneo corporal (body scan) y respiración acompañada con foco en exhalación prolongada.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DOLOR CRÓNICO Y SOMATIZACIÓN

Paciente: Mujer de 41 años, abogada, con diagnóstico de dolor pélvico crónico idiopático y colon irritable de 3 años de evolución. Acude atemorizada ante cada espasmo muscular, convencida de padecer un tumor no detectado.

Perfil MAIA-2 Basal (Medias 0 a 5):

- **Notar:** 4.8 / 5.0 (Hipervigilancia extrema de cualquier molestia visceral).
- **No-Preocuparse:** 0.8 / 5.0 (Catastrofismo absoluto; pánico inmediato ante el dolor).
- **Autorregulación:** 1.2 / 5.0 (Incapacidad de calmarse con la respiración; recurre a urgencias).
- **Confianza Corporal:** 0.6 / 5.0 (Vivencia de su cuerpo como «una máquina defectuosa y traicionera»).

Formulación Clínica: Desregulación interoceptiva grave. La paciente hiperatendía las señales somáticas con un sesgo interpretativo catastrófico que incrementaba el tono simpático y el espasmo muscular.

Tratamiento Somático y Resultados: Programa de Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness para Dolor Crónico (MBSR): educación en neurobiología del dolor y ejercicios de no-lucha somática. A los 4 meses: No-Preocuparse subió a 3.2, Autorregulación a 3.6 y Confianza a 3.8, logrando una reducción del 60% en el consumo de analgésicos.

9. ALERTAS CLÍNICAS Y GESTIÓN DE RIESGO

ALERTA EN TRAUMA Y DISOCIACIÓN SOMÁTICA

En supervivientes de abuso sexual o negligencia grave, pedirles directamente que “atendan a las sensaciones de su cuerpo” puede disparar flashbacks disociativos o crisis de pánico. Avanzar con intervenciones somáticas tituladas (pendulación).

REGLA DE INVERSIÓN OBLIGATORIA

Los reactivos de No-Distraerse y No-Preocuparse deben invertirse rigurosamente antes de promediar las subescalas para asegurar que puntuaciones altas reflejen habilidades adaptativas y no evitación o pánico.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Mehling, W. E., et al. (2012). The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA). *PLoS ONE*, 7(11), e48230.
2. Mehling, W. E., et al. (2018). The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA-2). *PLoS ONE*, 13(12), e0208034.
3. Valenzuela-Moguillansky, C., & Reyes-Reyes, A. (2015). Psychometric properties of the Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness (MAIA) in a Chilean population. *Frontiers in Psychology*, 6, 120.
4. Craig, A. D. (2009). How do you feel—now? The anterior insula and human awareness. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(1), 59–70.